

Tout le monde autour d'une personne autiste en soutien intensif

Le guide cumulatif pour toute l'équipe entourant une personne autiste en soins assistés / établissement résidentiel / soutien intensif (tout âge) — famille et proches, médecins et cliniciens d'établissement, travailleurs de soutien et assistants personnels, et personnel infirmier/résidentiel. Une fiche de référence étendue ; à coupler avec les guides rapides par interlocuteur.

L'idée principale

L'autisme, à travers le **monotropisme**, signifie que l'attention d'une personne se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Pour une personne autiste en soutien intensif, les environnements de soins sont souvent les **plus difficiles de tous** : hostiles sur le plan sensoriel, perturbant les routines, riches en contacts physiques et en demandes imprévisibles. Beaucoup communiquent sans parole (CAA, comportement, tiers de confiance) et peuvent ne pas enregistrer ou signaler la douleur avant qu'elle ne soit sévère. Le principe commun unique pour toute l'équipe est radical et simple : **lire tout comportement comme une communication sur un besoin non comblé** — douleur, peur, surcharge ou perte de routine — et protéger la prévisibilité, les objets, les intérêts et la volonté. La dignité et le consentement reposent sur le fait de travailler *avec* la personne, sans jamais supposer d'incapacité.

Ce qui aide dans tous les environnements

- **Recherchez la douleur et les causes physiques en premier** pour toute nouvelle détresse — la constipation, les douleurs dentaires, les infections ou un équipement mal ajusté sont des coupables courants et cachés.
- **Bâissez les soins autour de la prévisibilité** — personnel constant, même séquence, supports visuels, préavis pour chaque changement.
- **Réduisez la charge sensorielle** — salle calme, lumière tamisée, réduction des bips et des odeurs fortes ; préservez les objets, intérêts et routines de la personne.
- **Utilisez la prise de décision assistée** — expliquez de manière accessible et littérale ; laissez un temps de traitement ; consultez l'accompagnateur de confiance et tout profil de communication/avance.
- **Établissez un plan calme et écrit pour le meltdown/shutdown** : réduisez la stimulation, assurez la sécurité, donnez du temps et de l'espace — ne contenez pas et ne punissez pas.
- **Documentez et partagez un profil sensoriel, de communication et d'aménagements raisonnables individualisé** avec toute l'équipe.
- **Gardez l'équipe coordonnée et cohérente** — un profil partagé et un ensemble d'approches convenues entre la famille, les cliniciens, les travailleurs de soutien et le personnel infirmier préviennent la détresse causée par les changements de personnel et les malentendus.

- **Planifiez chaque transition et admission à l'avance** — un « passeport santé » écrit, des photos du nouvel environnement et un contact connu transforment les moments les plus difficiles (hôpital, déménagement, changement de personnel) en moments gérables.
- **Gardez les aides à la communication et la CAA disponibles et fonctionnelles** — pour beaucoup, la CAA est leur voix ; un appareil manquant ou déchargé est une urgence, pas un inconvénient.

Ce qu'il faut éviter dans tous les environnements

- Étiqueter la détresse comme « comportementale » avant d'avoir exclu la douleur et la surcharge.
- Utiliser la contention ou la sédation comme première réponse au meltdown/shutdown.
- Supprimer des routines, des objets ou des intérêts « pour leur propre bien ».
- Supposer un manque de capacité à partir d'une communication atypique ou non verbale.
- Laisser des aides à la communication, des objets ou des routines se « perdre » lors des transmissions ou des admissions — la continuité est la sécurité ; documentez-la et transmettez-la.

Notes rapides pour chaque personne entourant l'individu

Famille et proches

Vous êtes leur mémoire, leur défenseur et leur continuité. Partagez et mettez à jour un profil d'une page (intérêts, routines, besoins sensoriels, signes d'alerte précoces, ce qui les régule). Insistez pour que la douleur soit exclue en premier pour toute nouvelle détresse ; protégez les routines, les objets et les intérêts ; poussez pour une prise de décision assistée et un passeport santé ; visitez et connectez-vous via leur intérêt.

Médecins et cliniciens d'établissement

Traitez toute détresse nouvelle ou croissante comme un **signal d'alarme médical** jusqu'à ce que la douleur, l'infection, la constipation, les problèmes dentaires et les causes sensorielles/environnementales soient exclus. Dépistez le burnout autistique sous charge chronique. Utilisez la prise de décision assistée et un passeport santé ; documentez les aménagements efficaces.

Travailleurs de soutien et assistants personnels (personnel résidentiel)

Vous êtes l'environnement quotidien. Personnel et séquence constants, supports visuels, objets et intérêts préservés, plan calme pour le meltdown/shutdown (réduire la stimulation, assurer la sécurité, pas de contention). Documentez et partagez un profil individualisé ; plaidez auprès de la famille et des cliniciens.

Personnel infirmier et résidentiel

La douleur et les causes physiques en premier ; prévisibilité et routines préservées ; réduction de la charge sensorielle ; prise de décision assistée ; plan calme et écrit pour le meltdown/shutdown ; passeport santé pour toute

admission. Lisez tout comportement comme une communication sur un besoin non comblé.

Quand chercher plus de soutien

Traitez toute **détresse nouvelle ou croissante** comme un signal d'alarme médical jusqu'à ce que la douleur, l'infection, la constipation, les problèmes dentaires et les causes sensorielles/environnementales soient exclus. Dépistez le **burnout autistique** sous charge chronique. Impliquez des **équipes spécialisées en autisme/handicap mental** et en orthophonie (CAA). Planifiez chaque admission avec un « passeport santé/hospitalier » et un plan de meltdown/shutdown convenu qui priorise la sécurité sur la contention.

Note sur le genre

Les femmes en soutien intensif sont particulièrement sous-identifiées et mal servies ; leur détresse est encore plus souvent mal interprétée. Appliquez la même rigueur pour exclure la douleur et la surcharge avec toute l'équipe, quel que soit le mode de présentation ou de communication.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour la famille** (Partie 5, maisons de retraite et hôpitaux), le **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.5 & 4) et la brève sur le **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.** À adapter à l'individu ; la famille le connaît le mieux.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interoception/pain); Autism Society (2025, meltdowns/shutdowns); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space); AASPIRE AHAT. Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.